Clínica Cirúrgica · Estações OSCE — Cabeça e Pescoço

3 estações de 5 minutos · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#CP-1** — Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos (Tumor de parótida — benigno x maligno (adenoma pleomórfico))
2. **#CP-2** — Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar (Traqueostomia — indicações e manejo da obstrução/deslocamento da cânula)
3. **#CP-3** — Nódulo no pescoço achado em ultrassom (Manejo do nódulo tireoidiano (TI-RADS e Bethesda))

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-1 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. Consulta de primeira vez.

PACIENTE

Cláudia, 45 anos, sexo feminino, professora.

QUEIXA PRINCIPAL

Nódulo indolor na região pré-auricular direita, de crescimento lento, há cerca de 2 anos.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame físico dirigidos, pesquisando sinais que diferenciem neoplasia benigna de maligna (os achados serão fornecidos mediante solicitação).
2. Formule a hipótese diagnóstica e solicite a investigação.
3. Proponha o tratamento e oriente a paciente.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-1 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
122/78 mmHg	72 bpm	14 irpm	36,4 °C	64 kg	1,63 m

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, corada, hidratada.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- REGIÃO PAROTÍDEA DIREITA: nódulo de 2,5 cm, localizado anterior e inferiormente ao lóbulo da orelha, de consistência fibroelástica, superfície lobulada, MÓVEL, indolor, sem aderência à pele, sem sinais flogísticos
- NERVO FACIAL: função preservada nos 5 ramos (enruga a testa, fecha os olhos com força, sorri, assobia, contrai o platisma) — House-Brackmann I
- CAVIDADE ORAL / OROFARINGE: óstio do ducto de Stensen sem secreção purulenta; parede lateral da orofaringe sem abaulamento (lobo profundo sem extensão parafaríngea)
- PESCOÇO: sem linfonodomegalias palpáveis
- PELE DO COURO CABELUDO E FACE: sem lesões suspeitas

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ULTRASSONOGRAFIA DA PARÓTIDA (entregar se solicitada): nódulo sólido, hipoecoico, bem delimitado, de contornos lobulados, 2,4 x 1,8 cm, no lobo superficial da parótida direita, com reforço acústico posterior; sem linfonodos cervicais suspeitos. PAAF (entregar se solicitada): componente epitelial e mioepitelial em matriz condromixoide — compatível com ADENOMA PLEOMÓRFICO (Milão: categoria IVA — neoplasia benigna).

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-1 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico SOMENTE se o candidato descrever a palpação do nódulo E a avaliação do nervo facial / pescoço / cavidade oral. A US e a PAAF só são entregues se solicitadas. Se o candidato indicar biópsia incisional ou "retirada só do caroço" (enucleação), ANOTAR como erro crítico.

PERFIL DO PACIENTE

Cláudia, 45 anos, professora de ensino fundamental, casada, 2 filhos. Não fuma. Sem comorbidades. Sem radioterapia prévia em cabeça e pescoço.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	"Apareceu esse carocinho aqui na frente da orelha. No começo era pequenininho, e foi crescendo devagar."
Dor	"Não dói nada. Só me incomoda porque dá pra ver."
Crescimento rápido	"Não, cresceu bem devagarinho, em dois anos."
Rosto torto / fraqueza facial	"Não, meu rosto tá normal, não tenho nada torto."
Relação com alimentação	"Não muda quando eu como, não incha nem dói."
Pergunta ativa	"Doutor, isso é câncer? Se operar, meu rosto pode ficar paralisado?"

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Medo de cirurgia porque uma vizinha "ficou com a boca torta depois de operar a parótida" — só revela se perguntada sobre preocupações/medos
- Sem tabagismo e sem exposição solar intensa — revela se perguntada

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansiosa, mas colaborativa. Tem receio de paralisia facial e pergunta sobre isso de forma insistente.

GABARITO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-1 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos

Neoplasia benigna de glândula parótida direita (lobo superficial) — adenoma pleomórfico (tumor misto benigno), confirmado por PAAF, sem sinais clínicos de malignidade.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Carcinoma mucoepidermoide / carcinoma adenoide cístico / carcinoma ex-adenoma pleomórfico — sinais de alarme ausentes: dor, paralisia facial, crescimento rápido, fixação à pele ou planos profundos, linfonodomegalia cervical.
- Tumor de Warthin (cistadenolinfoma) — segundo tumor benigno mais comum; típico de homens idosos tabagistas, frequentemente bilateral; a PAAF diferencia.
- Linfonodo intraparotídeo metastático (ex.: CEC cutâneo ou melanoma de couro cabeludo/face) — examinar a pele da face e do couro cabeludo.
- Parotidite / sialolitíase — sai: ausência de dor, de relação com a alimentação e de sinais inflamatórios.

CONTEXTO CLÍNICO

Cerca de 80% dos tumores salivares ocorrem na parótida e cerca de 80% deles são benignos; o adenoma pleomórfico é o mais comum. Quanto menor a glândula, maior a chance de malignidade (submandibular ~50%, glândulas menores ~70–80%).

JUSTIFICATIVA

Nódulo pré-auricular de crescimento lento, indolor, móvel, fibroelástico, com nervo facial íntegro e sem linfonodos = perfil benigno. US com nódulo sólido lobulado e PAAF com matriz condromixoide confirmam adenoma pleomórfico.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo e velocidade de crescimento
- Dor
- Paralisia/fraqueza facial
- Relação com alimentação
- Tabagismo, radioterapia prévia
- Lesões de pele em face/couro cabeludo

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação do nódulo (tamanho, consistência, mobilidade, aderência)
- Avaliação dos ramos do nervo facial
- Exame da cavidade oral/orofaringe (lobo profundo)
- Palpação das cadeias linfonodais cervicais

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Ultrassonografia (ou RM, preferida para lobo profundo/planejamento)	Caracterizar o nódulo e sua relação com a glândula.	Nódulo sólido lobulado no lobo superficial.
Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) guiada por US	Diferencia benigno de maligno e orienta a extensão da cirurgia; não implanta tumor (ao contrário da biópsia incisional).	Adenoma pleomórfico.

CONDUTA ESPERADA

- Parotidectomia superficial (ou parcial) com identificação e preservação do nervo facial — tratamento de escolha, mesmo para tumor benigno, pelo risco de crescimento contínuo e transformação maligna

(carcinoma ex-adenoma pleomórfico, ~5–10% em longo prazo)
- NÃO realizar enucleação nem biópsia incisional (alto risco de recidiva por pseudocápsula/implante)
- Orientações: risco de paresia facial transitória (~20–40%) e definitiva (< 5%); síndrome de Frey (sudorese gustatória); dormência do lóbulo da orelha (nervo auricular magno)
- Em suspeita de malignidade: parotidectomia total ± esvaziamento cervical ± radioterapia

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar que a lesão é benigna, mas deve ser retirada
- Abordar o medo da paralisia facial com dados honestos
- Checar entendimento

ERROS CRÍTICOS

- Não avaliar a função do nervo facial
- Indicar biópsia incisional ou enucleação do nódulo
- Indicar apenas observação para adenoma pleomórfico em paciente jovem
- Tratar com antibiótico como se fosse parotidite

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-1 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Caroço na frente da orelha que cresce devagar há 2 anos

CHECKLIST — TUMOR DE PARÓTIDA (BENIGNO x MALIGNO)

ANAMNESE E EXAME	Pts	Avaliação
Pesquisou sinais de alarme de malignidade (dor, crescimento rápido, paralisia facial) NCCN Head and Neck Cancers, 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Examinou o nódulo (mobilidade, consistência, aderência) Cummings Otolaryngology, 7ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou os ramos do nervo facial Cummings, 7ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Palpou linfonodos cervicais e examinou cavidade oral/orofaringe NCCN 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Hipótese de neoplasia benigna de parótida (adenoma pleomórfico), citando diferenciais malignos OMS — Classificação de Tumores de Cabeça e Pescoço, 2022	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou US/RM e PAAF Sistema de Milão para Citopatologia de Glândulas Salivares, 2023	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA E COMUNICAÇÃO	Pts	Avaliação
Indicou parotidectomia superficial com preservação do nervo facial Cummings, 7ª ed.; SBCCP	1	☐ A ☐ P ☐ I
Contraindicou biópsia incisional/enucleação Cummings, 7ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou riscos (paresia facial, Frey) e acolheu o medo da paciente CFM — Código de Ética Médica, 2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-2 · Enfermaria de Cirurgia — chamado da enfermagem · nível difícil

Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar

CENÁRIO

Enfermaria de cirurgia, 3h da manhã. A técnica de enfermagem chama você com urgência. Há no quarto: fonte de O_2, aspirador, cateter de aspiração, bolsa-válvula-máscara, máscara facial e máscara pediátrica, kit de traqueostomia com cânula do mesmo tamanho e um número menor, material de intubação orotraqueal, seringa de 10 mL e oxímetro.

PACIENTE

Sr. Álvaro, 63 anos, 6º dia pós-operatório de traqueostomia cirúrgica eletiva (cânula plástica com balonete/cuff e endocânula), realizada por intubação prolongada após AVC. Respira espontaneamente com O_2 por máscara de traqueostomia. Via aérea superior pérvia.

QUEIXA PRINCIPAL

Paciente agitado, com desconforto respiratório e saturação caindo.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o atendimento verbalizando cada passo (os achados serão fornecidos conforme suas ações).
2. Ao final, cite três indicações de traqueostomia.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-2 · Enfermaria de Cirurgia — chamado da enfermagem · nível difícil

Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	SpO2	Glasgow
158/94 mmHg	124 bpm	34 irpm	82% com O_2 pela traqueostomia	13

EXAME FÍSICO GERAL

Agitado, sudoreico, com tiragem supraclavicular e intercostal, uso de musculatura acessória.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- TRAQUEOSTOMIA: cânula em posição aparente; ao colocar a mão/capnógrafo na cânula, fluxo de ar MUITO REDUZIDO; ruído de secreção
- AUSCULTA: murmúrio vesicular diminuído globalmente, roncos
- SEQUÊNCIA DE RESPOSTAS ÀS AÇÕES: (1) Retirada da endocânula: endocânula com grande rolha de secreção espessa; após retirada, FLUXO DE AR MELHORA PARCIALMENTE
- (2) Passagem de cateter de aspiração: o cateter PASSA facilmente pela cânula; aspira-se grande quantidade de secreção espessa
- (3) Após aspiração e O_2: SpO_2 sobe para 95%, FR 22 irpm, FC 100 bpm, paciente mais calmo

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-2 · Enfermaria de Cirurgia — chamado da enfermagem · nível difícil

Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar

NOTA AO AVALIADOR

Fornecer os achados conforme as ações do candidato, na sequência acima. Se o candidato tentar ventilar com bolsa pela cânula antes de checar a permeabilidade, informar: “há grande resistência, o tórax não expande”. Se o candidato não retirar a endocânula/não aspirar e decidir trocar a cânula às cegas, informar “SpO_2 75%” e ANOTAR erro crítico. Se o candidato verbalizar desinsuflar o cuff e retirar a cânula: aceitar, desde que antes tenha verificado que o cateter não passa — neste caso o cateter PASSA, logo esse passo não é necessário. Ao final, pedir as indicações de traqueostomia se o candidato não as citar.

PERFIL DO PACIENTE

Sr. Álvaro, 63 anos, hipertenso, AVC isquêmico há 3 semanas, intubado por 12 dias; traqueostomizado há 6 dias. Tem secreção espessa e umidificação inadequada nas últimas horas.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser abordado	“(Paciente não consegue falar — aponta para a cânula, faz sinais de falta de ar.)”
Técnica de enfermagem (se questionada)	“Doutor, ele começou a ficar agitado há uns 10 minutos. O umidificador desconectou e ninguém percebeu. Ele tem muita secreção.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

O umidificador estava desconectado (secreção espessa) — a técnica de enfermagem só informa se perguntada sobre o que aconteceu antes

COMPORTAMENTO DO ATOR

Paciente agitado, com sinais de desconforto respiratório; melhora visivelmente após aspiração.

GABARITO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-2 · Enfermaria de Cirurgia — chamado da enfermagem · nível difícil

Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar

Obstrução da cânula de traqueostomia por rolha de secreção (falta de umidificação), em traqueostomia recente (< 7 dias, trajeto ainda não maturado), resolvida com retirada da endocânula e aspiração.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Deslocamento/decanulação acidental (falso trajeto) — o cateter de aspiração não passaria; exigiria desinsuflar o cuff e retirar a cânula.
- Broncoespasmo — sibilos difusos; o cateter passa e não há rolha.
- Pneumotórax — complicação precoce da traqueostomia; MV abolido unilateral e hipertimpanismo.
- Sangramento traqueal / fístula traqueoinominada — sangramento pela cânula (sangramento sentinela).

CONTEXTO CLÍNICO

Obstrução e deslocamento da cânula são as emergências mais comuns em traqueostomizados e causa de mortes evitáveis. Em traqueostomias com menos de 7 dias, o trajeto não está maturado e a reinserção às cegas pode criar falso trajeto.

JUSTIFICATIVA

Dessaturação súbita com fluxo de ar reduzido pela cânula, secreção espessa e falha da umidificação; melhora após retirada da endocânula (com rolha) e aspiração confirmam obstrução por secreção.

ANAMNESE ESPERADA

Perguntar à equipe: tempo de traqueostomia, tipo de cânula (cuff, endocânula), via aérea superior pérvia, o que aconteceu antes

EXAME FÍSICO ESPERADO

Avaliar sinais de desconforto, verificar fluxo de ar pela cânula e pela boca, auscultar o tórax

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Oximetria e capnografia (quando disponível)	Monitorizar ventilação e confirmar permeabilidade da via aérea.	Melhora da SpO_2 após desobstrução.
Radiografia de tórax (após estabilização)	Afastar pneumotórax e checar posição da cânula.	—

CONDUTA ESPERADA

- Algoritmo de emergência em traqueostomia (NTSP — National Tracheostomy Safety Project): 1) chamar ajuda (equipe de via aérea)
- 2) O_2 em alto fluxo pela FACE e pela TRAQUEOSTOMIA
- 3) avaliar permeabilidade: retirar a endocânula (e válvula de fala/filtro, se houver)
- 4) passar cateter de aspiração — se passa, a cânula está pérvia/bem posicionada: aspirar e reavaliar
- 5) se o cateter NÃO passa: desinsuflar o cuff; se não melhorar, RETIRAR a cânula
- 6) se o paciente não respira após retirada: RCP se sem pulso; ventilar pela boca/nariz (ocluindo o estoma) ou pelo estoma com máscara pediátrica/máscara laríngea
- 7) via aérea definitiva: intubação orotraqueal (tubo avançado além do estoma) — em traqueostomia < 7 dias, evitar reinserção às cegas pelo estoma (risco de falso trajeto)
- Prevenção: umidificação, aspiração regular, limpeza da endocânula, cânula reserva à beira-leito
- Indicações de traqueostomia: ventilação mecânica/intubação prolongada (> 10–14 dias, ou previsão), obstrução de via aérea superior (tumores, trauma de face/laringe, paralisia bilateral de pregas vocais, edema), toalete brônquica em pacientes com muita secreção, proteção da via aérea em rebaixamento crônico de consciência/disfagia neurológica grave, facilitar desmame ventilatório, parte de cirurgias de cabeça e pescoço

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Liderança, pedido de ajuda precoce, comunicação clara com a enfermagem
- Orientar a equipe sobre umidificação

ERROS CRÍTICOS

- Não chamar ajuda / não oferecer O_2 pela face e pela traqueostomia
- Ventilar com bolsa através de cânula possivelmente obstruída/deslocada sem checar permeabilidade
- Trocar a cânula às cegas em traqueostomia recente (< 7 dias) sem antes retirar a endocânula e passar o cateter
- Esquecer que a via aérea superior pode ser usada para oxigenar/intubar

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-2 · Enfermaria de Cirurgia — chamado da enfermagem · nível difícil

Paciente traqueostomizado que começou a dessaturar

CHECKLIST — EMERGÊNCIA EM TRAQUEOSTOMIA

ABORDAGEM INICIAL	Pts	Avaliação
Chamou ajuda e solicitou monitorização NTSP — Emergency Tracheostomy Management, 2012/2024	1	☐ A ☐ P ☐ I
Ofereceu O_2 em alto fluxo pela face E pela traqueostomia NTSP	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

DESOBSTRUÇÃO — SEQUÊNCIA	Pts	Avaliação
Retirou a endocânula NTSP	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Passou o cateter de aspiração para checar permeabilidade e aspirou NTSP	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Verbalizou plano se o cateter não passasse: desinsuflar cuff → retirar cânula → ventilar boca/estoma → IOT NTSP; Difficult Airway Society	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Reconheceu risco de falso trajeto em traqueostomia < 7 dias NTSP	1	☐ A ☐ P ☐ I

CAUSA E INDICAÇÕES	Pts	Avaliação
Identificou a falta de umidificação como causa e orientou prevenção NTSP	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou 3 indicações de traqueostomia (IOT prolongada, obstrução de via aérea superior, toalete brônquica/proteção de via aérea) Sabiston, 21ª ed.; Cummings, 7ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-3 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Nódulo no pescoço achado em ultrassom

CENÁRIO

Ambulatório. A paciente retorna com exames solicitados pela UBS.

PACIENTE

Renata, 39 anos, sexo feminino, bancária.

QUEIXA PRINCIPAL

Notou um “caroço” no pescoço ao se olhar no espelho; trouxe TSH e ultrassonografia.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete os exames entregues e indique o próximo passo.
2. Interprete o resultado da citologia (entregue após sua solicitação adequada).
3. Defina a conduta e oriente a paciente.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-3 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Nódulo no pescoço achado em ultrassom

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso
118/76 mmHg	74 bpm	14 irpm	36,3 °C	60 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, eutireoidiana clinicamente.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- PESCOÇO: nódulo de cerca de 2 cm em lobo direito da tireoide, endurecido, indolor, móvel à deglutição; sem linfonodos cervicais palpáveis
- LARINGOSCOPIA (se solicitada): pregas vocais com mobilidade preservada

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
TSH	1,8 mUI/L	0,4–4,0 mUI/L
T4 livre	1,1 ng/dL	0,9–1,7 ng/dL

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE (entregar no início): nódulo sólido, MARCADAMENTE HIPOECOICO, mais alto que largo, margens irregulares/lobuladas, com microcalcificações, medindo 2,1 x 1,6 x 1,5 cm, em terço médio do lobo direito — ACR TI-RADS 5 (TR5). Linfonodos cervicais sem características suspeitas. CITOLOGIA (PAAF guiada por US — entregar somente se solicitada): Bethesda VI — maligno: carcinoma papilífero de tireoide.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-3 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Nódulo no pescoço achado em ultrassom

NOTA AO AVALIADOR

Entregar TSH, T4L e US no início. Entregar a citologia SOMENTE se o candidato indicar PAAF. Se o candidato pedir cintilografia de tireoide, informar “não indicada com TSH normal — reveja a conduta” e ANOTAR. Se perguntar sobre irradiação e história familiar, usar o roteiro.

PERFIL DO PACIENTE

Renata, 39 anos, bancária, casada, sem filhos, deseja engravidar. Sem comorbidades.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Sintomas compressivos	“Não tenho dificuldade pra engolir nem rouquidão.”
Radiação na infância	“Não, nunca fiz radioterapia.”
Família	“Minha tia teve câncer de tireoide, operou e tá bem.”
Pergunta ativa (após PAAF)	“É câncer, então? Vou morrer? E vou poder engravidar?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Tia materna com câncer de tireoide — só revela se perguntada sobre história familiar
- Deseja engravidar em 1 ano — só revela se perguntada sobre planos ou na pergunta ativa

COMPORTAMENTO DO ATOR

Calma no início; ao receber o resultado de câncer, fica assustada e chorosa. Acalma-se se o candidato explicar o bom prognóstico.

GABARITO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-3 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Nódulo no pescoço achado em ultrassom

Nódulo tireoidiano TI-RADS 5 de 2,1 cm em paciente eutireoidiana, com PAAF Bethesda VI — carcinoma papilífero de tireoide (cT2 N0, sem extensão extratireoidiana, sem linfonodos suspeitos).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Nódulo benigno (coloide/adenoma) — sai pela citologia Bethesda VI.
- Carcinoma folicular — a citologia não diferencia adenoma de carcinoma folicular (Bethesda IV); aqui a citologia é de papilífero.
- Carcinoma medular — associar se calcitonina elevada ou história familiar de NEM2; citologia distinta.
- Nódulo autônomo (quente) — afastado por TSH normal.

CONTEXTO CLÍNICO

Nódulos tireoidianos são muito comuns (até 68% à US), e 7–15% são malignos. O carcinoma papilífero é o mais frequente e tem excelente prognóstico (sobrevida > 95% em 10 anos).

JUSTIFICATIVA

Fluxo: TSH normal → US → PAAF conforme TI-RADS e tamanho (TR5 ≥ 1 cm = PAAF). Citologia Bethesda VI (maligno; risco de malignidade 97–99%) → cirurgia.

ANAMNESE ESPERADA

- Sintomas compressivos (disfagia, dispneia, rouquidão)
- Irradiação cervical na infância
- História familiar de câncer de tireoide/NEM
- Crescimento rápido

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação da tireoide e cadeias cervicais
- Avaliação da voz/laringoscopia pré-operatória

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TSH	Primeiro exame: se TSH baixo → cintilografia (nódulo quente raramente é maligno); se normal/alto → US + PAAF conforme critérios.	Normal.
Ultrassonografia de tireoide e cervical	Classificar risco (TI-RADS) e avaliar linfonodos.	TR5, 2,1 cm; linfonodos normais.
PAAF guiada por US	TR5 ≥ 1 cm (ACR) — indicação de punção.	Bethesda VI.
Laringoscopia pré-operatória	Documentar mobilidade das pregas vocais.	Normal.

CONDUTA ESPERADA

- Tratamento cirúrgico: tumor de 1–4 cm, sem extensão extratireoidiana e sem linfonodos (cN0) — lobectomia (hemitireoidectomia) ou tireoidectomia total são opções (ATA 2015/2025); decisão compartilhada considerando fatores de risco e preferência (tireoidectomia total facilita radioiodo e seguimento com tireoglobulina)
- Esvaziamento central terapêutico apenas se linfonodos acometidos
- Radioiodo conforme estratificação de risco pós-operatória
- Levotiroxina após tireoidectomia total, com alvo de TSH conforme risco

- Orientações: excelente prognóstico; gestação possível após tratamento e com função tireoidiana controlada (após radioiodo, aguardar 6–12 meses)
- Riscos cirúrgicos: lesão do nervo laríngeo recorrente (rouquidão), hipoparatireoidismo (hipocalcemia)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar o diagnóstico de câncer com empatia (protocolo SPIKES)
- Enfatizar o bom prognóstico
- Responder sobre gestação
- Checar compreensão

ERROS CRÍTICOS

- Solicitar cintilografia com TSH normal como próximo passo
- Não indicar PAAF para nódulo TI-RADS 5 ≥ 1 cm
- Prescrever levotiroxina para “reduzir o nódulo” em vez de cirurgia
- Indicar apenas seguimento ultrassonográfico após citologia Bethesda VI

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cabeça e Pescoço · Estação #CP-3 · Ambulatório — Cirurgia de Cabeça e Pescoço · nível moderado

Nódulo no pescoço achado em ultrassom

CHECKLIST — NÓDULO TIREOIDIANO

INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Interpretou TSH normal e reconheceu que cintilografia não está indicada ATA Thyroid Nodule Guidelines, 2015; SBEM	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Classificou o nódulo como TI-RADS 5 (características suspeitas) ACR TI-RADS, 2017	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou PAAF guiada por US (TR5 ≥ 1 cm) ACR TI-RADS, 2017	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou fatores de risco (irradiação, história familiar, sintomas compressivos) ATA 2015	1	☐ A ☐ P ☐ I

CITOLOGIA E CONDUTA	Pts	Avaliação
Interpretou Bethesda VI como maligno (carcinoma papilífero) Sistema Bethesda, 3ª ed., 2023	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou cirurgia (lobectomia ou tireoidectomia total, tumor 1–4 cm cN0) ATA 2015/2025	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou US cervical/laringoscopia pré-operatória e riscos (nervo laríngeo recorrente, hipoparatireoidismo) ATA 2015; SBCCP	1	☐ A ☐ P ☐ I

COMUNICAÇÃO	Pts	Avaliação
Comunicou o diagnóstico com empatia, destacou bom prognóstico e respondeu sobre gestação Baile WF — Protocolo SPIKES, Oncologist 2000	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado